

Số: 633 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc ngủ và an thần DEXMED KABI 200 μ g/2ml

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc DEXMED KABI 200ug/2ml. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây:

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có thành phần hoạt chất là dexmedetomidin 200 microgam/2ml, là một chất chủ vận đối kháng chọn lọc trên thụ thể alpha-2 có tác dụng ức chế thần kinh giao cảm.
- Cơ chế tác dụng: ức chế thần kinh giao cảm thông qua việc giảm giải phóng noradrenalin ở đoạn cuối dây thần kinh giao cảm., tác dụng an thần được điều hòa thông qua việc giảm bắn nhanh lực, hạt nhân noradrelanin chiếm ưu thế, nằm trong thân não.
- Dạng bào chế: dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền, không màu.

2. Chỉ định và liều dùng của thuốc

Chỉ định	Liều dùng
An thần cho bệnh nhân người lớn trong ICU cần mức độ an thần không sâu hơn mức thức tỉnh khi đáp ứng với kích thích bằng lời	Bệnh nhân đã đặt nội khí quản và an thần có thể chuyển sang dexmedetomidin với tốc độ truyền 0.7 ug/kg/giờ sau đó điều chỉnh 0.2-1.4 ug/kg/giờ để đạt được mức độ an thần mong muốn, liều tối đa 1.4 ug/kg/giờ.
An thần cho bệnh nhân người lớn không đặt nội khí quản trước và/hoặc trong các thủ thuật chẩn đoán hoặc phẫu thuật yêu cầu an thần	<i>Liều an thần ban đầu:</i> truyền liều nạp 1.0ug/kg trong 10 phút <i>Liều an thần duy trì:</i> liều truyền duy trì bắt đầu 0.6-0.7 ug/kg/giờ và được chỉnh liều để đạt được hiệu quả mong muốn.

Cách dùng: Dexmed Kabi được pha loãng trong các dung dịch tiêm truyền (NaCl 0.9%, Glucose 5%, Ringer Lactat, Manitol 20%) để đạt được nồng độ mong

muốn là 4ug/ml hoặc 8ug/ml, sau đó tiêm truyền tĩnh mạch bằng một thiết bị truyền có kiểm soát.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Mẫn cảm với dexmedetomidin hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc;
- Block tim tiến triển (độ 2 hoặc 3) trừ khi đã được đặt máy tạo nhịp;
- Huyết áp thấp không được kiểm soát;
- Tình trạng bệnh lý mạch máu não cấp tính.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THUỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI

Chỉ định	Liều dùng
An thần cho bệnh nhân người lớn trong ICU cần mức độ an thần không sâu hơn mức thức tỉnh khi đáp ứng với kích thích bằng lời	Bệnh nhân đã đặt nội khí quản và an thần có thể chuyển sang dexmedetomidin với tốc độ truyền 0.7 ug/kg/giờ sau đó điều chỉnh 0.2-1.4 ug/kg/giờ để đạt được mức độ an thần mong muốn, liều tối đa 1.4 ug/kg/giờ.
An thần cho bệnh nhân người lớn không đặt nội khí quản trước và/hoặc trong các thủ thuật chấn đoán hoặc phẫu thuật yêu cầu an thần	Liều an thần ban đầu: truyền liên tục 1.0 ug/kg trong 10 phút Liều an thần duy trì: liên tục duy trì bắt đầu 0.6-0.7 ug/kg/giờ và được chỉnh liều để đạt được hiệu quả mong muốn.